SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2026
(v05)

DỰ THẢO

HƯỚNG DẪN

Áp dụng mô hình phân công chăm sóc người bệnh tại các khoa, bộ phận

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

– Chọn mô hình phân công chăm sóc phù hợp cho từng khoa, bảo đảm mỗi người bệnh (NB) nội trú có một điều dưỡng/hộ sinh (ĐD/HS) chịu trách nhiệm chăm sóc chính trong mỗi ca và tiến tới suốt đợt điều trị.

– Làm căn cứ triển khai và minh chứng tiêu chí C6.3 (NB được chăm sóc toàn diện) và C6.1 (hệ thống quản lý điều dưỡng, bàn giao ISBAR).

– Áp dụng cho các khoa lâm sàng có giường, Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu - HSTC & Chống độc, PT-GMHS, Thận nhân tạo; các khoa cận lâm sàng áp dụng phần phân công theo vị trí (mục III.4).

II. CĂN CỨ

– Bài 2 “Các mô hình phân công chăm sóc”, sách “Quản lý Điều dưỡng trưởng khoa 2026”, Bộ Y tế, NXB Y học (Thư viện tài liệu 2026, mục 01).

– Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện (Cần xác minh điều khoản trích dẫn).

– Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiêu chí C6.1, C6.3 (phiên bản áp dụng 2026: Cần xác minh); hồ sơ C6.3 của Bệnh viện (QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01).

– Hồ sơ C6.1: SOP-C6.1-02 Bàn giao người bệnh theo ISBAR; BM-C6.1-01 Bảng kiểm bàn giao; BM-C6.1-04 Phiếu bàn giao người bệnh giữa các ca trực theo ISBAR (bản giấy và Google Form).

– Số giường thực kê và nhân lực ĐD-KTY-HS theo dữ liệu NT Nursing (Thống kê giường bệnh các khoa; Danh sách ĐD-KTY-NHS chính thức T9/2026).

III. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO TỪNG KHOA

Nguyên tắc chung: không áp dụng mô hình theo nhiệm vụ thuần tuý cho NB nội trú. Khoa đủ điều kiện áp dụng chăm sóc toàn diện (5–7 NB/1 ĐD ca ngày theo tài liệu đào tạo); khoa chưa đủ áp dụng theo nhóm, mỗi nhóm có ĐD trưởng nhóm, và lập lộ trình tiến tới toàn diện. Mô hình theo nhiệm vụ chỉ dùng tạm khi cấp cứu hàng loạt hoặc thiếu nhân lực đột xuất, ĐDT khoa ghi lại lý do.

Ghi chú số liệu: số NB và số ĐD do Phòng Điều dưỡng cung cấp ngày 31/10/2026 (NB trung bình; “hành chánh” là ĐD làm giờ hành chính, “trực” là ĐD trực theo ca). NB/ĐD ca ngày = số NB ÷

số ĐD có mặt ca ngày (ĐD hành chánh, cộng ĐD trực ban ngày nếu có). Nhi, Nội Tổng quát chưa có số ĐD ca ngày nên vẫn ước tính bằng (nhân lực − 1 ĐDT) × 50%. Liên Chuyên khoa chưa có số. ĐDT khoa rà lại trước khi ban hành.

1. Khoa lâm sàng có giường nội trú

Khoa	**Giường thực kê / NB thực tế**	**Nhân lực**	**NB/ĐD ca ngày (ước tính)**	**Mô hình đề xuất**	**Cách tổ chức**
Nội Tổng quát	55 / 80 NB (31/10)	16	~10	Theo nhóm	Quá tải (80 NB/55 giường): 3 nhóm theo dãy buồng, mỗi nhóm có trưởng nhóm; ưu tiên ĐD chăm sóc chính cố định cho NB cấp I; hộ lý hỗ trợ chăm sóc cơ bản; đề xuất bổ sung/điều động nhân lực trước khi chuyển sang toàn diện.
Nhi	55 / 78 NB (31/10)	15	~11	Theo nhóm	Quá tải (78 NB/55 giường): 3 nhóm theo buồng/nhóm tuổi; trưởng nhóm lập KHCS; tăng cường hướng dẫn người nhà cùng chăm sóc (cho ăn, vệ sinh, theo dõi sốt) theo phân cấp; trẻ nặng giao ĐD cố định; đề xuất bổ sung nhân lực.
Phụ Sản	40 / 19 NB	5 trực + 5 hành chánh	~4 (đêm ~4)	Toàn diện (mẹ – con)	1 HS/ĐD phụ trách cả sản phụ và trẻ sơ sinh của buồng mình (4–5 cặp mẹ con); ca đêm 5 ĐD trực chia buồng tương tự; phòng sinh giữ phân công theo vị trí (đỡ đẻ, hồi sức sơ sinh).
Nội Tiêu hóa	29 giường / ~29 NB	8	~7	Toàn diện (sát ngưỡng)	2 ĐD ca ngày, mỗi người 1 dãy buồng (~7 NB); ĐDT kiêm trưởng nhóm, nhận thêm NB khi đông; nếu vượt 7 NB/ĐD chuyển tạm sang theo nhóm. Cần khoa xác nhận số ĐD ca ngày.
Truyền Nhiễm (Nội Nhiễm)	25 / ~20 NB	3 trực + 2 hành chánh	~7–10	Theo nhóm (1 nhóm) → toàn diện khi ca ngày đủ 3 ĐD	Ca ngày 2 ĐD hành chánh (+1 ĐD trực): ĐDT làm trưởng nhóm, chia NB theo buồng, buồng cách ly giao ĐD cố định trong ca; khi có 3 ĐD ca ngày (~7 NB/ĐD) chuyển sang toàn diện.
Ngoại Tổng quát	20 / ~10 NB	3 (chung khối ngoại: 3 trực + 5 hành chánh)	~3–4	Toàn diện	Ca ngày: 2 ĐD hành chánh của khối ngoại phụ trách NB Ngoại TQ (~5 NB/ĐD), NB sau mổ giao ĐD cố định đến khi ra viện; ca đêm trực chung khối ngoại.
Ngoại Chấn thương	18 / ~12 NB	3 (chung khối ngoại)	~4	Toàn diện	Ca ngày: 2–3 ĐD hành chánh khối ngoại phụ trách (~4–6 NB/ĐD), ưu tiên ĐD cố định cho NB sau mổ, bó bột, kéo tạ. Hai khoa ngoại: 22 NB, 3 ĐD trực đêm (~7 NB/ĐD) chia theo khoa, bàn giao ISBAR riêng từng khoa.
Cấp cứu - HSTC & Chống độc	12 / ~8 NB	11 (7 ĐD ca ngày)	~1	Toàn diện (hồi sức) + theo vị trí ở khu cấp cứu, theo nhiệm vụ khi cấp cứu hàng loạt	Buồng hồi sức: 1 ĐD : 1–2 NB theo mức độ nặng; ĐD còn lại phân vị trí khu cấp cứu (phân loại, hồi sức, thủ thuật); chuyển ngay sang nhiệm vụ khi có thảm hoạ/cấp cứu hàng loạt.
YHCT -	~250 kỹ	7 KTY, 2 y	~23 kỹ	Theo nhóm kỹ	Chia nhóm theo loại kỹ thuật (vận

PHCN	thuật/ngày	sĩ, 2 ĐD	thuật/người/ngày	thuật + người phụ trách liệu trình	động trị liệu, điện – nhiệt trị liệu, châm cứu – xoa bóp); mỗi NB được giao 1 KTY/y sĩ phụ trách cố định suốt liệu trình để theo dõi tiến triển; 2 ĐD phụ trách đón tiếp, theo dõi DHST, chăm sóc NB nội trú, GDSK. Khối lượng cao: theo dõi để đề xuất nhân lực.
Liên Chuyên khoa (TMH, Mắt, RHM, Da liễu)	Chưa có số	17	—	Theo nhóm theo chuyên khoa	Mỗi chuyên khoa một nhóm; NB nội trú giao ĐD chăm sóc chính; phòng thủ thuật phân theo vị trí.

2. Khoa, bộ phận đặc thù

Khoa/bộ phận	Mô hình đề xuất	Cách tổ chức
PT - GMHS (5 giường hồi tỉnh, 12 NV)	Theo vị trí trong phòng mổ; toàn diện tại hồi tỉnh	Phòng mổ: dụng cụ viên, chạy ngoài, phụ mê theo ca mổ (bản chất nhiệm vụ, bắt buộc có bảng kiểm an toàn phẫu thuật). Hồi tỉnh: 1 ĐD : 2 NB, bàn giao ISBAR khi chuyển về khoa.
Thận nhân tạo (3 BS, 10 ĐD, 2 hộ lý; 24 máy HD + 3 máy HDF online; ~57 lượt lọc/ngày, 3 ca/ngày, trực 24 giờ)	Toàn diện theo ca lọc máu: mỗi ĐD phụ trách cố định một cụm máy/NB	Khoảng 19 NB mỗi ca; nếu 3 ĐD/ca thì ~6 NB/ĐD, 4 ĐD/ca thì ~5 NB/ĐD. Mỗi ĐD nhận cố định một cụm máy liền nhau và các NB lọc máu định kỳ ở cụm đó qua các buổi (theo dõi cân nặng khô, đường vào mạch máu, biến chứng trong lọc); 1 ĐD giữ vai trò trưởng ca, không nhận máy hoặc nhận ít máy để xử trí cấp cứu, tiếp nhận NB mới; hộ lý hỗ trợ vệ sinh máy, giường, chất thải. Tỷ lệ số máy/ĐD tối đa theo hướng dẫn chuyên môn lọc máu của Bộ Y tế: Cần xác minh. 10 ĐD cho 3 ca và trực 24 giờ là sát; cần lịch phân ca cụ thể để kiểm tra.
Khám bệnh (39 NV)	Theo vị trí, có người phụ trách NB trong lượt khám	NB lưu ngắn nên phân vị trí (đón tiếp – phân luồng, bàn khám, thủ thuật, tư vấn); ĐD bàn khám chịu trách nhiệm NB của bàn từ gọi số đến hoàn tất chỉ định; NB nặng có ĐD đưa đi và bàn giao.

3. Khoa cận lâm sàng và bộ phận hỗ trợ

Khoa Xét nghiệm, CĐHA - TDCN, Dược, KSNK, Tổ Tiêm chủng không phân công chăm sóc NB nội trú; áp dụng phân công theo vị trí công việc, nhưng phải có người chịu trách nhiệm NB trong thời gian NB ở khoa (tiếp nhận, nhận dạng NB ≥ 2 yếu tố, theo dõi, bàn giao lại khoa lâm sàng). Phòng Điều dưỡng (2 nhân sự) giữ vai trò hướng dẫn, giám sát, tổng hợp.

IV. NHIỆM VỤ

Người thực hiện	Nhiệm vụ
Điều dưỡng trưởng khoa	Chọn mô hình theo bảng mục III, trình Trưởng khoa; lập bảng phân công hằng ngày (mẫu BM-PCCS-01); điều chỉnh nhân lực giữa các nhóm; đi buồng cùng bác sĩ; kèm cặp ĐD còn yếu; báo cáo PĐD khi phải chuyển tạm sang mô hình theo nhiệm vụ.
ĐD trưởng nhóm	Lập và cập nhật kế hoạch chăm sóc cho NB trong nhóm; phân NB cho ĐD trong nhóm; giám sát, hỗ trợ; trao đổi với bác sĩ điều trị.
ĐD/HS chăm sóc chính	Nhận định, thực hiện chăm sóc theo phân cấp; tự giới thiệu tên với NB và người nhà; ghi phiếu chăm sóc; bàn giao ISBAR cuối ca và ghi phiếu BM-C6.1-04 (giấy hoặc Google Form) cho NB mình phụ trách, ghi rõ mô hình phân công ca; hướng dẫn người nhà cùng chăm sóc.
Hộ lý	Hỗ trợ chăm sóc cơ bản theo phân công của ĐD chăm sóc chính, không làm kỹ thuật

	chuyên môn.
Phòng Điều dưỡng	Hướng dẫn, tập huấn, giám sát hằng tháng; tổng hợp chỉ số (lấy từ bảng kết quả Google Form BM-C6.1-04 và bảng kiểm BM-C6.1-01); đề xuất bổ sung nhân lực cho khoa không đủ điều kiện.

V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (đề xuất)

Thời gian	Nội dung	Kết quả
11/2026	Tập huấn Bài 2 và SOP-C6.1-02 cho ĐDT, ĐD trưởng nhóm; khoa chọn mô hình, gửi bảng phân công mẫu về PĐD; bắt đầu dùng phiếu BM-C6.1-04 (giấy hoặc Google Form) mỗi lượt giao ca	100% khoa có mô hình đăng ký; 100% khoa có NB lưu dùng BM-C6.1-04
12/2026	Áp dụng thử toàn diện tại Phụ Sản, Nội Tiêu hóa, HSTC (buồng hồi sức), Ngoại TQ và Ngoại CT; Nội TQ, Nhi, Truyền Nhiễm áp dụng theo nhóm; YHCT-PHCN áp dụng người phụ trách liệu trình	Bảng phân công BM-PCCS-01 dán tại buồng/ghi HSBA
Quý I/2027	Giám sát bằng bảng kiểm BK-PCCS-01; sơ kết, điều chỉnh; mở rộng toàn diện sang Truyền Nhiễm, Nội TQ, Nhi khi giảm quá tải hoặc bổ sung nhân lực	Báo cáo sơ kết, đề xuất nhân lực Nội TQ, Nhi, Truyền Nhiễm, YHCT-PHCN
Từ quý II/2027	Duy trì, đưa chỉ số vào giám sát chất lượng điều dưỡng hằng tháng	Minh chứng C6.3

VI. CHỈ SỐ GIÁM SÁT

Chỉ số	Cách đo	Mục tiêu đề xuất
Tỷ lệ NB nội trú có ĐD chăm sóc chính ghi rõ trên bảng phân công	Số NB có tên ĐD phụ trách / tổng NB, kiểm tra ngẫu nhiên	≥ 95%
Tỷ lệ NB/người nhà biết tên ĐD chăm sóc mình	Phỏng vấn ngẫu nhiên 5 NB/khoa/tháng	≥ 80%
Tỷ lệ NB được giữ cùng ĐD chăm sóc chính ≥ 3 ngày liên tiếp (ca ngày)	Đối chiếu bảng phân công	≥ 70% (khoa toàn diện)
Tỷ lệ lượt bàn giao đủ 4 mục kiểm tra cuối	Phiếu BM-C6.1-04 / trang "Tổng hợp theo khoa" của Google Form; ĐDT chấm ngẫu nhiên bằng BM-C6.1-01 để đối chiếu	≥ 90%
Số lượt phải tạm theo nhiệm vụ	Mục "Mô hình phân công ca" trên BM-C6.1-04 / Google Form	Theo dõi, phân tích nguyên nhân

Mục tiêu là đề xuất của Phòng Điều dưỡng, cần Hội đồng Điều dưỡng thống nhất.

VII. BIỂU MẪU

Dùng kèm: BM-C6.1-04 Phiếu bàn giao người bệnh giữa các ca trực theo ISBAR (hồ sơ C6.1). Bảng phân công BM-PCCS-01 và phiếu BM-C6.1-04 phải khớp nhau: ĐD giao/nhận trên phiếu là ĐD chăm sóc chính trên bảng phân công.

BM-PCCS-01. Bảng phân công chăm sóc người bệnh (theo ca)

Khoa: …… Ngày: ……/……/20…… Ca: ☐ Sáng ☐ Chiều ☐ Đêm Mô hình: ☐ Toàn diện ☐ Theo nhóm ☐ Tạm theo nhiệm vụ (lý do: ……)

Nhóm	ĐD trưởng nhóm	ĐD/HS chăm sóc chính	Buồng/giường phụ trách	Số NB	NB cấp I	Hộ lý hỗ trợ	Ghi chú

Không ghi họ tên NB trên bảng dán tại buồng; chỉ ghi số buồng, số giường.

BK-PCCS-01. Bảng kiểm giám sát áp dụng mô hình phân công chăm sóc

TT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Khoa có mô hình phân công đã đăng ký với PĐD			
2	Bảng phân công ca hiện tại đầy đủ, đúng mẫu BM-PCCS-01			
3	Mỗi NB có 1 ĐD/HS chăm sóc chính được ghi tên			
4	Số NB/ĐD ca ngày phù hợp mô hình (toàn diện ≤ 7)			
5	NB cấp I được giao ĐD có kinh nghiệm			
6	ĐD trưởng nhóm có kế hoạch chăm sóc cập nhật cho NB trong nhóm			
7	Phỏng vấn NB/người nhà: biết tên ĐD chăm sóc			
8	Bàn giao ca theo ISBAR có ĐD chăm sóc chính tham gia, phiếu BM-C6.1-04 ghi đủ			
9	ĐDT đi buồng cùng bác sĩ trong ngày			
10	Nếu chuyển tạm sang theo nhiệm vụ: có ghi lý do, báo PĐD			

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Hội đồng Điều dưỡng;
- ĐDT các khoa;
- Lưu: PĐD.

NGƯỜI SOẠN

CKIĐD. Võ Hồng Thái